Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Lagoa Vermelha

Rua Protásio Alves, 80, 3º andar - Bairro: Alto Pedregal - CEP: 95300000 - Fone: (54)3046-9850 - Email: frlagverm1vciv@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5005583-05.2024.8.21.0057/RS

REQUERENTE: TEREZINHA FATIMA VIEIRA DA SILVA

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Relatório.

TEREZINHA FÁTIMA VIEIRA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência para fornecimento de medicamento em face do IPE-SAÚDE — INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, partes já qualificadas, relatando, preliminarmente, a concessão de prioridade na tramitação do feito, fundamentando seu pleito no fato de ser pessoa idosa, contando com 69 (sessenta e nove) anos na data de ajuizamento da ação. Invocou, para tanto, o disposto no artigo 71 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e no artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos fatos, disse ser portadora de Neoplasia de vesícula biliar avançada por acometimento peritoneal, patologia classificada sob o CID 10 C22. Em razão de seu quadro clínico, foi prescrito tratamento de imunoterapia com o medicamento Durvalumabe, na dosagem de 1.500 mg a cada 21 (vinte e um) dias, associado à quimioterapia. Disse que o imunizante fora prescrito e assinado por sua médica oncologista, Dra. Júlia Pastorello, CRM-RS n.º 33.728. Disse que a comprovação da doença se deu por meio de exames oncológicos e anatomopatológico, realizados na Clínica IPPF. Alegou que, embora o fármaco seja aprovado pela ANVISA e conste no rol da ANS, o seu fornecimento foi indevidamente negado pela autarquia ré. Sustentou ser beneficiária do IPE-Saúde e do plano PAMES, sob cartão n.º 73.01313894.00.3, na condição de professora aposentada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contribuindo regularmente com o plano de saúde por longos anos. Informou que a solicitação administrativa para o fornecimento do medicamento foi realizada em 11 de novembro de 2024, através da Guia de Autorização n.º 03003491, sendo o pleito indeferido pela ré. Relatou que a doença se manifesta de forma muito sintomática e com rápida evolução, causando-lhe forte dor, inchaço nas mamas, fraqueza, entre outros sintomas, tornando urgente o início do tratamento prescrito pelo tempo estimado de 10 a 12 meses. Diante da negativa e da urgência, e por ser aposentada, a autora afirmou não possuir condições financeiras para arcar com o tratamento, cujo custo estimado, segundo o orçamento mais baixo apresentado, é de R$ 50.327,79 (cinquenta mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), para 1.500 mg. Ressaltou que, em todas as farmácias orçadas, esse medicamento é vendido em 500 mg, ou seja, a autora precisará de 3 doses para totalizar o receitado que é 1.500 mg. Além deste custo, mencionou arcar com despesas relativas a outras comorbidades, como obesidade, diabetes e hipertensão, bem como custos de deslocamento até a cidade de Passo Fundo–RS para a realização das sessões de quimioterapia. Relatou que o IPE deve cobrir medicamentos de alto custo para tratamento oncológico sempre que houver prescrição médica, já que o plano de saúde IPE tem cobertura para o câncer, o que consequentemente deve fornecer o tratamento completo. Disse ser imprescindível que a requerida seja obrigada, liminarmente, a fornecer o medicamento, em razão do risco de danos irreversíveis à saúde da autora, e a autorizar o tratamento do medicamento conforme prescrição médica até que seja necessário, suportando os valores despendidos com o tratamento que injustificadamente se recusou a custear. Relatou que, segundo pareceres médicos, o tratamento com o imunizante durvalumabe aumenta as chances de cura, e, caso a autora não o inicie urgentemente o tratamento, corre risco de progressão da doença. Nos fundamentos jurídicos, fundamentou sua pretensão no direito à vida e à saúde, garantias constitucionais insculpidas nos artigos 1º (dignidade da pessoa humana), 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, e no artigo 153 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Citou os princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da igualdade de acesso e da solidariedade financeira que regem o sistema de saúde. No plano infraconstitucional, invocou a Lei n.º 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), destacando os artigos que asseguram a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Especificamente quanto à obrigação do réu, mencionou a Lei n.º 12.134/2004, que em seu artigo 2º estabelece que o Plano IPE-SAÚDE integra os atendimentos médicos, hospitalares e os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento. Citou, ainda, os artigos 8º e 9º da Resolução n.º 21/79 do IPERGS, que reforçam a cobertura para atos necessários ao tratamento. Concluiu ser vedado a autarquia negar-se a fornecer o necessário tratamento ao segurado, à vista da notória gravidade da situação e considerando o entendimento pacificado junto ao Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado para o paciente. Disse que a referida medicação foi receitada com base em utilização de medicações anteriores receitadas pela médica junto ao paciente, sendo indicada, para o seu caso específico, afastando os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo substituição. Adicionalmente, argumentou que o Código de Ética Médica (Resolução CFM n.º 1.931/09), em seu artigo 16, veda que disposições regimentais de instituições de saúde limitem a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos para o diagnóstico e tratamento, salvo em benefício do paciente. Relatou ser inadmissível que a autarquia se recuse a fornecer determinado tipo de tratamento, estando prevista a referida doença no Protocolo Oncológico, não sendo óbice a dispensação do fármaco postulado, uma vez tendo sido esta a prescrição médica, devendo a parte ré arcar com os custos necessários à manutenção da vida do segurado. Em sede de tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, argumentou a presença da probabilidade do direito, com base nos fundamentos jurídicos expostos, e do perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento irreversível de seu estado de saúde e até mesmo de óbito caso não inicie imediatamente o tratamento prescrito. Requereu liminarmente que seja disponibilizado pela requerida à autora o referido medicamento (Durvalumabe). Sendo assim, requereu o deferimento da medida liminar, para compelir o réu a fornecer o medicamento DURVALUMABE 1.500 mg a cada 21 dias, conforme prescrição médica. Subsidiariamente, em caso de descumprimento, a determinação de sequestro de valores das contas do réu ou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para a aquisição do fármaco. Pleiteou a fixação de multa diária (astreintes) em valor não inferior a um salário mínimo, em caso de descumprimento da ordem judicial. No mérito, requereu a

procedência total da ação, para confirmar a tutela de urgência e condenar o réu a fornecer o medicamento na quantidade e pelo tempo necessários ao tratamento, estimado em 10 a 12 meses. Requereu, por fim, a concessão da gratuidade da justiça e a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Juntou documentos.

Em decisão, recebida a inicial, deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) à autora e concedida a tramitação prioritária do feito, em virtude da idade da requerente. Deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando ao IPE Saúde o fornecimento do medicamento solicitado, no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores. A decisão ressaltou a natureza da doença como coberta pelo plano e a comprovação da necessidade do fármaco, determinando, contudo, a coparticipação da segurada nas despesas de acordo com sua categoria de filiação, a ser comprovada pelo Instituto. Por fim, determinada a citação da parte ré e a solicitação de nota técnica ao E-NatJus Estadual (evento 3, DOC1).

Em manifestação, o réu informou ao juízo o cumprimento da decisão liminar, comunicando que a autorização para o tratamento com o medicamento Durvalumabe 1500 mg foi liberada em 02/12/2024. Adicionalmente, sugeriu a necessidade de renovação periódica do relatório médico para a continuidade das liberações do tratamento, a fim de garantir a pertinência e a manutenção da eficácia da medida (evento 9, DOC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação, relatando, em síntese, quanto ao sistema de saúde dos servidores públicos e da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, que tem sua cobertura definida pelas leis, decretos e normativas institucionais, nos termos do art. 4°, caput, da Lei Complementar Estadual n.° 15.145/2018, e sua administração regulamentada pelo IPE Saúde, autarquia estadual de mesmo nome criada pela já referida lei. Relatou que, diferentemente dos planos de saúde privados, que possuem contratos com seus beneficiários e necessitam de cláusula contratual expressa para a negativa de cobertura, o IPE Saúde é instituído por Lei e administrado por uma Autarquia estadual, determinando a observação integral dos princípios aplicáveis à Administração Pública, principalmente a legalidade. Quanto à sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde (FAS/RS), argumentou que a manutenção da assistência é custeada por recursos do Fundo de Assistência à Saúde (FAS/RS), conforme a Lei Complementar Estadual n.º 12.066/2004. Relatou que a profusão de incisos que detalham as receitas do FAS/RS na legislação específica, embora aparentemente vasta, não se traduz em abundância de recursos. A maioria dessas receitas, como as contribuições mensais dos servidores e do Estado, possui caráter fixo ou depende de dotações orçamentárias e definições legais, o que limita significativamente a capacidade do Órgão Gestor de aumentar a arrecadação de forma flexível para atender a demandas imprevisíveis ou não previstas. As rendas eventuais são, por sua própria definição, incertas. Dessa forma, a capacidade de atuação para incremento das receitas é diminuta, enquanto os custos com saúde tendem a ser crescentes, especialmente diante do surgimento constante de novas tecnologias e medicamentos de alto custo. Disse que a imposição judicial de cobertura para tratamentos e medicamentos de elevado custo, não previstos nos protocolos e nas tabelas da autarquia, gera um desequilíbrio financeiro que afeta a capacidade do IPE-SAÚDE de cumprir suas obrigações para com a integralidade dos seus segurados. Tal interferência jurisdicional, ao impor despesas sem a correspondente fonte de custeio e sem a prévia avaliação de impacto orçamentário e atuarial, subverte a lógica de gestão pública, violando o princípio da separação de Poderes e a vedação ao aumento de despesa sem a necessária fonte de custeio. A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, deve pautar-se pela cautela, evitando decisões que possam comprometer o sistema como um todo e prejudicar a coletividade de beneficiários que dependem de sua sustentabilidade. Quanto à limitação da cobertura para tratamentos oncológicos no âmbito do IPE-Saúde, disse que as despesas com procedimentos e tratamentos que devem ser custeadas pelo Sistema IPE Saúde estão restritas àquelas constantes nas normas editadas pelo Instituto, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018. Disse que não pode admitir nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Disse que, especificamente sobre os tratamentos oncológicos, a Instrução Normativa nº 09, de 27 de março de 2024, com suas alterações posteriores, regulamenta a forma como se dá inclusão de novos tratamentos na cobertura do IPE Saúde, devendo passar por crivo rigoroso de demonstração de benefícios clínicos relevantes. Relatou que, atualmente, a medicação solicitada pela parte autora não faz parte da cobertura para o tratamento da doença que lhe acomete, assim, não há como ser deferido o tratamento pleiteado pela autora, visto que a concessão infringiria as normas administrativas que regram a cobertura do Sistema IPE Saúde, subvertendo, por consequência, o equilíbrio financeiro que pressupõe a manutenção do sistema. Quanto à necessidade de comprovação de evidências científicas, disse que, mesmo compreendendo-se que a cobertura do IPE-SAÚDE não esteja adstrita exclusivamente aos atos internos que a preveem, é imperativo que a concessão judicial de tratamentos observe critérios rigorosos. Disse que o custeio de tratamentos pela coletividade que mantém o IPE-SAÚDE depende, conforme Instrução Normativa, da comprovação de evidências científicas robustas, preferencialmente por meio de revisão sistemática com meta-análise ou estudos clínicos randomizados e duplo-cegos. Disse que a Lei dos Planos de Saúde (Lei Federal n.º 9.656/1998), em sua redação dada pela Lei Federal n.º 14.454/2022, é cristalina ao definir que o fornecimento de tratamentos não expressamente previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionado à comprovação de requisitos técnicos específicos. Reforçou que, em se tratando de um tratamento postulado judicialmente que não integra o rol de coberturas administrativas para a enfermidade da autora, a comprovação da eficácia deste tratamento, sob a ótica das ciências da saúde e baseada em evidências científicas e plano terapêutico, é uma exigência imprescindível. Dessa forma, sustentou que não é admissível que a concessão judicial de tratamentos não previstos em seus atos administrativos ignore a necessidade de demonstração de evidências científicas sobre a eficácia do tratamento. Assim, para a concessão de tratamento não previsto nos protocolos clínicos do IPE-SAÚDE, é fundamental que a parte autora demonstre evidências científicas acerca da efetividade da tecnologia pleiteada, recaindo sobre ela o ônus probatório, principalmente em face da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a entidades de autogestão. Sendo assim, requereu o encaminhamento de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) para emissão de parecer técnico-científico sobre a existência de evidências científicas relativas à eficácia do tratamento postulado para a doença que acomete a parte autora. No mérito, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a regularidade da atuação administrativa do IPE-SAÚDE na negativa de cobertura. Em caso de eventual condenação, o reconhecimento da isenção do IPE-SAÚDE quanto ao pagamento de custas processuais, conforme legislação pertinente. Protestou a produção de todas as provas admitidas em direito.

Houve réplica (evento 19, DOC1).

Em manifestação, o réu reiterou o pedido de produção de nota técnica pelo NatJus, argumentando que a recusa anterior fora equivocada, pois o serviço também abrange a saúde suplementar (evento 21, DOC1).

O NatJus devolveu, pela segunda vez, a solicitação, mantendo a justificativa de que a demanda não é contra o SUS (evento 28, DOC1).

Em manifestação, a autora requereu a prolação de sentença de procedência para condenar o réu ao custeio integral do tratamento prescrito com Durvalumabe, enquanto indicado pela médica responsável, visando garantir seu acesso à saúde e dignidade humana (evento 40, DOC1).

Em manifestação, a autora informou não ter outras provas a serem produzidas, requerendo o julgamento do feito com base nos documentos já acostados (evento 47, DOC1).

Em manifestação, o réu, diante da recusa do NatJus Nacional, requereu a produção de Nota Técnica pelo Nat-Jus TelessaúdeRS-UFRGS (evento 49, DOC1).

Foi juntada aos autos a Nota Técnica nº 409344, elaborada pelo TelessaúdeRS-UFRGS (evento 53, DOC1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Decido. Fundamentação.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame **do mérito**.

Cuida-se de ação de medicamentos em que a parte autora postula o fornecimento do fármaco Durvalumabe, 1500 mg, a cada 21 (vinte e um) dias, até progressão ou toxidade limitante, conforme laudo médico acostado à inicial, a fim de realizar o tratamento da patologia que lhe acomete, qual seja, "*Neoplasia de vesícula biliar avançada por acometimento peritoneal*" (CID 10 C22).

Inicialmente, frisa-se que é dever do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul garantir a saúde física e mental dos servidores vinculados ao Plano de Assistência Médica do Instituto. Portanto, é desta autarquia o dever de garantir os preceitos constitucionais. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece: "*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*"

Com efeito, a Lei nº 12.134/2004, a qual versa sobre a assistência médica oferecida pelo Plano IPE-SAÚDE, em seu art. 2º, dispõe: "*Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde*."

Os arts. 8º e 9º, da Resolução nº 21/79, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, referem:

> *"Art. 8º. O Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.*
>
> *§ 1º. O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa, sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.*
>
> *Art. 9º. A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:*
>
> *1 – Emergências*
>
> *2 – Consultas Médicas*
>
> *3 – Serviços Complementares*
>
> *4 – Tratamento Ambulatorial*
>
> *5 – Tratamento Hospitalar"*

Por outro lado, em princípio, apenas os atendimentos psiquiátricos e as cirurgias plásticas estéticas ou não éticas são excluídas da cobertura, nos termos dos arts. 411 e 422, da Resolução anteriormente citada. Dessa forma, os dispositivos anteriormente mencionados evidenciam a amplitude da cobertura, que abrange, inclusive, o fornecimento do medicamento do paciente.

Se dentre as especialidades médicas cobertas pelo IPE-SAÚDE encontram-se "os atos necessários ao tratamento", e não envolvendo o pedido o fornecimento de cirurgia plástica ou não ética, não verifico razão plausível a amparar a negativa do instituto réu. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é facultado ao plano selecionar o tipo de tratamento oferecido ao segurado:

> *AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR.*
>
> ***1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.***
>
> *2.- "É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013).*
>
> *3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013). (Grifei)*
>
> *AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE*

CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes.

2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 20/09/2013). (Grifei)

Nesse sentido, também decide o TJ/RS:

AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO PLANO IPE-SAÚDE. TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO AVASTIN. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não deve ser tolhido o direito da parte autora de ter custeado pelo IPE-SAÚDE o tratamento médico completo que necessita, com os medicamentos indicados pelo médico assistente, porquanto a Lei Complementar Estadual nº 12.134/2004 e a Resolução nº 21/79 preveem que serão cobertos pelo IPE-SAÚDE os "atos necessários ao tratamento". 2. Cabe ao profissional habilitado indicar o tratamento e os medicamentos necessários a sua realização, a fim de tratar de forma adequada a doença que acomete sua paciente, não cabendo ao IPERGS discutir sobre a forma do tratamento, devendo custear as despesas de acordo com a prescrição médica. 3. A ausência de previsão orçamentária e da reserva do possível são argumentos que não constituem óbice ao acolhimento da pretensão da parte autora, em especial porque não há nos autos prova de que o IPERGS não tenha condições de arcar com o custo do medicamento solicitado, tampouco que existam outras prioridades a serem atendidas. 4. O direito à indenização por dano moral deve ser caracterizado quando há constrangimento ilegal ou abusivo, violando os direitos de personalidade do indivíduo. 5. Hipótese em que a autora recebeu o atendimento médico necessário, inexistindo prejuízo a ensejar o dano moral pleiteado. 6. Logo, não havendo comprovação da conduta ilícita, culpa do agente, existência de dano, além do nexo de causalidade, inviável o pagamento de indenização por danos morais. 7. O IPERGS é autarquia estadual, pertencente ao Ente Federado Estadual, portanto, no que diz respeito a sua condenação ao pagamento das custas processuais, este é isento, porque o processo tramitou em cartório estatizado, situação essa que caracteriza o instituto da confusão previsto no artigo 381 do CCB. 8. De outra banda, suportará as despesas processuais, exceto as de oficial de justiça, de acordo com a Lei nº 8.121/1985 e decidido pelo Órgão Especial desta Corte na ADI nº 70038755864 e no IIn nº 70041334053. 9. Reexame Necessário, conhecido de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula nº 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição. 10. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo Nº 70064929748, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 24/06/2015)

Ressalto não desconhecer a determinação de que o segurado do IPE SAÚDE deve utilizar os procedimentos disponibilizados pelo plano de saúde, inclusive com requerimento administrativo da medicação postulada. Entretanto, diante da gravidade da situação, o plano de saúde deve fornecer o tratamento requerido, estando documentado o indeferimento do pedido administrativo formalizado pelo segurado.

No caso dos autos, a necessidade do uso dos medicamentos está demonstrada, principalmente, pelo laudo médico (evento 1, DOC8), assinado por profissional devidamente habilitado, o que é suficiente para comprovar a alegação da parte requerente, ou seja, a necessidade do uso do medicamento pleiteado. Salienta-se, no ponto, que o laudo médico não é genérico e especifica o motivo da prescrição.

Além disso, há parecer do NatJus favorável ao pedido da autora (evento 53, DOC1):

Conclusão

Tecnologia: DURVALUMABE

Página 3 de 4

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando que, apesar de modesto (aumento de pouco mais de um mês na sobrevida global), há evidência de benefício no uso do DURVALUMABE no tratamento das neoplasias malignas avançadas das vias biliares;
Conclui-se que há fundamento técnico na indicação do fármaco pleiteado.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

Nesse sentido, entendo que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir enquanto obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Destaco que o médico da parte autora, por acompanhar o paciente desde o início de seu problema, é quem - ao menos em tese - tem as melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, não podendo o direito constitucional à saúde ser limitado a uma simples tabela ou protocolo.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do RS tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão em tabela do IPERGS não é o suficiente para negativa de autorização de tratamento indicado por médico credenciado, conforme se verifica pelos precedentes a seguir:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PREVIDÊNCIA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEXAVAR 200MG. DEMANDANTE PORTADOR DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID 10 C 22 NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E HARMONIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ADEQUAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte era pacífica quanto à responsabilidade do IPERGS pela assistência médica dos seus segurados. Entendia-se que o artigo 2º da LC nº 12.134/04, combinado com as disposições da Resolução nº 21/1979, autorizava o entendimento no sentido de que o critério utilizado pela Administração Pública para definição dos serviços oferecidos pelo IPÊ-Saúde era o da exclusão expressa, de modo que, em princípio, todos os serviços de tratamento hospitalar ou ambulatorial curativos eram entendidos como custeados, exceto os expressamente excluídos. ***2. A Lei Complementar nº 15.145/18, que dispõe sobre o IPE-Saúde, refere que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos***

necessários ao diagnóstico e ao tratamento. O parágrafo primeiro do artigo 4º da nova lei, disciplina que os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do IPERGS restam excluídos da cobertura do plano de saúde, sendo oportuno assinalar que o parágrafo segundo exige, ainda, aprovação do Órgão Gestor para inclusão de novos procedimentos. 3. Contudo, em que pese as disposições da nova lei, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Inclusive, válido ressaltar que, de acordo com as Recomendações em Oncologia do próprio Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul elaboradas pelo Comitê Científico de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul as orientações ali constantes não têm pretensão de serem completas ou definitivas , restando destacado, ainda, que a atuação oncológica é um fenômeno continuado que requer revisões frequentes . 4. Assim, considerando que as Recomendações são de 2010, desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia. *5. O bloqueio de valores, cujo afastamento requer o agravante, é técnica utilizada para constranger o Estado (lato sensu) à satisfação do comando judicial em caso de eventual descumprimento do que restou consignado pelo juízo. Portanto, descabe afastar tal condenação. 6. Levando em consideração a singularidade do caso, eis que o demandante postula fornecimento por tempo indeterminado de medicamento de alto custo, razoável e necessária a realização de prova pericial médica, conforme requerido pelo agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079550992, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/12/2018)" (Grifei)*

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON METASTÁTICO. REGORAFENIBE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. DESCABE AO PLANO DE SAÚDE PÚBLICO SELECIONAR O TIPO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DO SEGURADO. ***A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da patologia de que padece o beneficiário. "Em que pese a edição da Lei Complementar nº. 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº. 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão no Protocolo Oncológico 2010 e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurada da autarquia. O Protocolo Oncológico aplicado pelo IPERGS se reporta ao ano de 2010, passados, pois, mais de sete anos, não tendo as orientações lá contidas pretensão de serem completas ou definitivas, sendo a atualização oncológica um fenômeno continuado que requer revisões frequentes.*** *" ("ut" trecho da ementa do Acórdão do Agravo de Instrumento Nº 70078464625). No caso concreto, restou demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado ao adequado tratamento da patologia que acomete o demandante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR PARTICULAR. REDUÇÃO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e parâmetro adotado por esta Câmara em situações similares. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70084158856, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 04-06-2020)" (Grifei)*

Sendo assim, é indiscutível a responsabilidade do IPE-Saúde pelo fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da parte autora, uma vez que está fundada na lei a sua responsabilidade em fornecer o atendimento médico e hospitalar e o tratamento, assim como os atos necessários ao diagnóstico e tratamento, razão pela qual não há como sustentar a justificativa da autarquia no sentido de que não há cobertura para o tratamento solicitado, bem como o médico que acompanha o paciente é quem tem condições de receitar o fármaco mais adequado ao tratamento, devendo prevalecer sua prescrição em face de parecer ou afirmação genérica acerca da possibilidade de utilização de medicamento diverso disponível nas tabelas da Autarquia.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por TEREZINHA FATIMA VIEIRA DA SILVA em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL para o fim de confirmar a antecipação de tutela e CONDENAR a parte ré a fornecer à requerente o medicamento Durvalumabe, 1500 mg, a cada 21 (vinte e um) dias, até progressão ou toxidade limitante, conforme o laudo médico (evento 1, DOC8), de forma continuada e na quantidade postulada pela parte autora, enquanto perdurar a sua necessidade.

Em caso de descumprimento, será bloqueado o valor correspondente.

Isento o requerido do pagamento de custas processuais.

No tocante aos honorários advocatícios devidos pelo requerido em favor do procurador da parte autora, que fixo de acordo com o valor indicado na Tabela de Honorários da OAB/RS para o ajuizamento de ação de procedimento ordinário cível (item 4.1), qual seja, R$ 8.441,84 (oito mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) com fundamento no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, uma vez que, no caso, o valor da causa não deve ser tomado como base de cálculo da verba honorária, pois não corresponde ao efetivo proveito econômico da parte litigante, eis que de valor inestimável.

Intimação e publicação automáticas. Sem necessidade de registro.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **GERSON LIRA, Juiz de Direito**, em 24/10/2025, às 18:41:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093382032v30** e o código CRC **23fe6cdf**.